

病期決定

■病期とは、病変の拡がりからみたがんの進行度の指標。

- T：腫瘍の大きさ
- N：リンパ節転移の有無
- M：遠隔転移の有無

■病期の決定は、**治療法の選択や予後の評価に重要な役割**を果たす。

■病期

- 臨床病期：治療前の検査で決定される。 ” c ” を付ける。
- 外科病期：手術時の肉眼・触診所見に基づく病期。 ” s ” を付ける。
- 病理病期：摘出した組織検体の病理学的評価により決定。 ” p ” を付ける。

■国際的には、UICC（国際対がん連合）のTNM分類を用いる。

■国内では、“がん取扱い規約” が用いられることが多い。

がん薬物療法の目的

① 進行がんに対する薬物療法

✓ 完全治癒（高感受性のがん）

- 急性骨髄性白血病，急性リンパ球性白血病，ホジキンリンパ腫，中高悪性度非ホジキンリンパ腫，胚細胞性腫瘍，絨毛がん，胎児性横紋筋肉腫，腎芽腫（Wilms腫瘍）

✓ 生存期間の延長，症状緩和，QOL維持

② 術後補助化学療法

✓ 再発防止（再発リスクの高い患者が対象）

③ 術前化学療法

✓ 治療成績の向上，ダウンステージによる切除率の向上，縮小手術による整容性・機能温存，薬物療法の効果の評価。

④ 化学放射線療法

✓ 局所制御効果を高め遠隔転移を抑えて生存率を向上，臓器や組織の形態・機能の温存。

⑤ 局所薬物療法

✓ 腫瘍組織に選択的，あるいは薬物移行の悪い組織への抗腫瘍効果を期待